



GUIA PARA PACIENTES

Hérnia de disco: quando é (e quando não é) cirurgia

o que a ressonância mostra, o que o corpo faz sozinho e quando não dá para esperar

Entenda por que a maioria das hérnias melhora sem operar, quais sinais pedem urgência e o que a cirurgia pode (e não pode) oferecer.



**DR. ROBERTO
RODRIGUES**
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
CIRURGIA DO JOELHO

CRM-CE 10806 · RQE 12256 · TEOT 17765 · @robertorodriguesmd

Material educativo. Não substitui consulta médica.

Palavra-chave no Instagram: **HERNIA**

Entre as vértebras existem os **discos**: um "amortecedor" com uma capa firme por fora e um miolo gelatinoso por dentro. Na hérnia de disco, parte desse miolo sai do lugar e pode encostar em um nervo.

Quando isso acontece na parte de baixo da coluna, a dor típica **desce pela perna**, muitas vezes abaixo do joelho, e pode vir com formigamento ou dormência. É a "dor ciática". Muitas vezes a perna dói mais do que as costas.

Hérnia de disco não é sinônimo de cirurgia. A maioria das pessoas melhora sem operar, e a hérnia costuma diminuir com o tempo [1]. Este guia explica quando a cirurgia faz sentido e quando não faz.

Para quem é:

Quem tem hérnia de disco lombar, confirmada na ressonância ou com suspeita, e quer entender as opções.

Para quem NÃO é:

- Quem tem algum sinal de alerta da Página 3. Aí não é hora de ler: é hora de procurar atendimento.
- Hérnia no pescoço (cervical). É outro assunto, com outros sinais.
- Quem já operou a coluna: siga a orientação da sua equipe.

Leia esta página antes de qualquer outra.

Procure um pronto-socorro HOJE se você tiver:

- **Perda do controle da urina ou das fezes**, dificuldade nova para urinar ou não sentir vontade de urinar.
- **Dormência na região "da sela"**: entre as pernas, ao redor do ânus e dos genitais.
- **Dor ciática nas DUAS pernas** junto com algum dos sinais acima.
- **Alteração nova da sensibilidade ou da função sexual** junto com os sinais acima.
- **Fraqueza na perna que está piorando**: pé "arrastando", tropeços, não conseguir ficar na ponta dos pés ou nos calcanhares.

Esses sinais podem indicar a **síndrome da cauda equina**: compressão grave dos nervos no fim da coluna. É rara, mas é **urgência**. O diagnóstico é feito com ressonância, e o tratamento costuma ser cirurgia para descomprimir os nervos. O atraso no diagnóstico piora o resultado [4].

Procure avaliação em poucos dias se:

- Teve **febre**, infecção recente ou tem imunidade baixa.
- Já teve **câncer**, mesmo há anos.
- Está **perdendo peso sem querer**.
- A dor começou após **queda ou trauma**.
- A dor **não alivia em nenhuma posição** e piora à noite.

Uma observação honesta: nenhum desses sinais, sozinho, quer dizer doença grave. Eles servem para dizer **quem precisa ser examinado antes** [3].

Muita gente sem dor tem "hérnia" no laudo

Num estudo clássico, 98 pessoas **sem dor nas costas** fizeram ressonância. **52%** tinham abaulamento de disco, **27%** tinham protrusão (um tipo de hérnia pequena) e 1% tinha extrusão (hérnia maior) [5].

Uma revisão com mais de 3 mil pessoas sem dor encontrou abaulamento de disco em **30% das pessoas de 20 anos** e em **84% das de 80 anos** [6]. Com a idade, o disco muda, assim como a pele e o cabelo.

O que isso quer dizer para você

O laudo descreve a imagem. **Ele não diz de onde vem a sua dor.** Quem liga uma coisa à outra é a consulta: onde dói, até onde a dor desce, força, sensibilidade e reflexos.

A hérnia "conta" quando **o lugar dela combina com o nervo que está dando sintoma**. As diretrizes só consideram a cirurgia quando a imagem é **coerente com os sintomas** [2].

Imagem sozinha não indica cirurgia. Laudo assustador com exame físico que não combina pede cautela, não pressa.

O corpo costuma "limpar" a hérnia

O material que saiu do disco provoca uma reação do próprio organismo, que muitas vezes vai reabsorvendo esse fragmento ao longo de semanas a meses.

Uma revisão de estudos estimou a chance de a hérnia **diminuir sem cirurgia** [7]:

- Hérnia sequestrada (o fragmento se soltou): **96%**.
- Hérnia extrusa (saiu bastante): **70%**.
- Protrusão (saiu pouco): **41%**.
- Abaulamento: **13%**.

Parece o contrário do que se imagina: **justamente as hérnias maiores e mais "soltas" são as que mais tendem a diminuir**. Hérnia grande na imagem não significa, por si só, cirurgia.

A diretriz da Sociedade Norte-Americana de Coluna (NASS) resume assim: a maioria dos pacientes melhora independentemente do tratamento, e as hérnias muitas vezes diminuem com o tempo [1].

Os limites dessa notícia boa

- Esses números vêm de **poucos estudos, pequenos e diferentes entre si** [7]. Servem como ordem de grandeza, não como promessa.
- A dor pode melhorar **antes** de a imagem mudar.
- Repetir a ressonância só para "ver se sumiu" raramente muda o tratamento (opinião clínica).

Sem sinal de alerta, o caminho inicial é o tratamento sem cirurgia. Ele não é "enrolação": é o que dá tempo para o corpo agir (Página 5).

O que costuma fazer parte

- **Manter-se ativo, dentro do possível.** Na ciática, ficar de cama não trouxe vantagem sobre se manter ativo [8].
- **Exercícios orientados**, de preferência com fisioterapeuta. As diretrizes incluem exercício no tratamento da dor lombar com ou sem ciática [2].
- **Remédios, decididos pelo médico.** Este guia não indica remédio nem dose. Vale saber: alguns remédios muito usados "para dor de nervo" e o corticoide em comprimido **não são recomendados** pela diretriz inglesa (NICE) para a ciática [2].
- **Infiltração na coluna (epidural)** pode ser considerada pelo médico em casos de ciática aguda e intensa. A própria NICE usa a palavra "considerar", o que, no texto dela, significa **evidência limitada** [2].

Por quanto tempo?

Os principais estudos compararam cirurgia e tratamento sem cirurgia em pessoas com **6 a 12 semanas** de ciática [9][10]. Por isso esse prazo é usado como referência para reavaliar. **Não é um relógio rígido:** depende da intensidade da dor, da evolução e de você.

1. Urgência: no mesmo dia

Síndrome da cauda equina (Página 3). Aqui não há "esperar para ver" [4].

2. Fraqueza importante ou que está piorando

Pé que arrasta cada vez mais, fraqueza que avança de uma semana para a outra: pede **avaliação rápida com especialista em coluna**. Essa conduta vem da prática e do consenso clínico, não de um ensaio específico.

Um detalhe honesto: num estudo com pessoas que já tinham fraqueza na perna havia 6 a 12 semanas, quem operou recuperou a força mais rápido, mas **depois de 1 ano a recuperação foi parecida** nos dois grupos: 81% com cirurgia e 80% sem [13]. Ou seja, fraqueza que **não está piorando**, sozinha, nem sempre obriga a operar.

3. Dor na perna forte que não cede

Dor ciática intensa que **não melhora após cerca de 6 a 12 semanas** de tratamento bem-feito, que atrapalha muito o sono e o trabalho, **com imagem coerente com o exame** [1][2]. A NASS sugere que, quando a cirurgia é indicada, ela seja feita antes de 6 meses [1].

Decisão compartilhada

No item 3, a cirurgia é **uma opção, não uma obrigação**. Pesam a intensidade da dor, o impacto na sua vida, os riscos e a sua preferência.

Geralmente não é motivo para cirurgia de hérnia: hérnia só no laudo, sem sintoma que combine, ou dor só nas costas, sem dor descendo pela perna (opinião clínica).

O que ela costuma oferecer: alívio mais rápido da dor na perna

No principal estudo holandês, 283 pessoas com ciática forte havia 6 a 12 semanas foram sorteadas para cirurgia precoce ou para continuar o tratamento sem cirurgia. **Quem operou cedo teve alívio mais rápido da dor na perna** [9].

O que ela não costuma oferecer: um resultado muito melhor a longo prazo

Depois de **1 ano**, os dois grupos estavam parecidos, e cerca de 95% em cada grupo relatavam recuperação. Detalhe importante: **39% do grupo sem cirurgia acabaram operando** ao longo do caminho, por não melhorarem [9]. Uma revisão dos estudos chegou à mesma conclusão: alívio mais rápido com a cirurgia e **sem diferença após 1 e 2 anos** [10]. No grande estudo americano (SPORT), os dois grupos melhoraram muito e mantiveram o resultado até 8 anos [11].

E quando a dor já dura meses?

Em pessoas com ciática de **4 a 12 meses**, a cirurgia reduziu mais a dor na perna em 6 meses do que continuar sem operar [12].

Riscos

Como toda cirurgia, tem riscos, que o cirurgião de coluna deve explicar um a um. E a hérnia **pode voltar** no mesmo nível, mesmo após uma cirurgia bem-feita [14].

Em resumo: a cirurgia costuma comprar tempo. Ela não garante um resultado melhor no longo prazo.

São orientações práticas de consultório (opinião clínica), não tratamentos testados em estudo. Exercícios específicos devem ser individualizados com o fisioterapeuta.

No dia a dia

- **Caminhadas curtas**, várias vezes ao dia, no ritmo que a dor permitir.
- **Troque de posição a cada 30 a 40 minutos**. Ficar muito tempo sentado costuma piorar a ciática.
- **Pegar algo do chão**: dobre os joelhos e mantenha o objeto perto do corpo, principalmente nos dias de crise.
- **Volte ao trabalho e à atividade física aos poucos**, aumentando a cada semana.

Posições de alívio

- **De barriga para cima, com as pernas apoiadas** num travesseiro alto ou no assento de uma cadeira (quadril e joelhos dobrados).
- **De lado**, com um travesseiro entre os joelhos.
- **Para levantar da cama**, role de lado, ponha as pernas para fora e empurre o colchão com as mãos ("rolar em bloco").

A regra da perna

- Movimento que faz a dor **descer mais pela perna** ou aumenta o formigamento no pé: **pare**.
- Movimento que faz a dor da perna diminuir, mesmo que as costas incomodem um pouco: costuma ser um bom sinal.

1. Decidir pela cirurgia (ou entrar em pânico) por causa do laudo.

Hérnia aparece em muita gente sem dor [5][6]. O que importa é se ela combina com os seus sintomas e com o seu exame.

2. Ficar de cama esperando passar.

Na ciática, o repouso no leito não trouxe vantagem sobre se manter ativo [8].

3. Esperar em casa com um sinal de alerta.

Perda de controle da urina ou das fezes, dormência na região da sela ou fraqueza piorando: **pronto-socorro no mesmo dia** [4].

4. Achar que a cirurgia é a solução definitiva, ou que operar é um "fracasso".

Nem uma coisa nem outra. A cirurgia alivia mais rápido, mas a longo prazo os resultados ficam parecidos com os de quem não opera [9][10], e a hérnia pode voltar [14]. Quando bem indicada, operar é uma escolha legítima.

5. Se automedicar ou repetir a receita de outra pessoa.

Remédio para dor de nervo, corticoide e anti-inflamatório têm riscos e nem todos funcionam na ciática [2]. Quem decide é o seu médico.

Procure avaliação médica se:

- A dor na perna **não melhora de forma clara em 4 a 6 semanas**.
- A dor é tão forte que **não deixa dormir ou trabalhar**.
- Há **formigamento, dormência ou fraqueza** na perna ou no pé, mesmo que leves.
- As crises **se repetem**.
- **A qualquer momento:** aparecer algum sinal da Página 3.

Esses prazos são de bom senso clínico, não uma regra rígida.

Como é a avaliação

Sou ortopedista e traumatologista, com atuação em cirurgia do joelho. Na consulta, avalio **com exame físico completo**: força, sensibilidade, reflexos e testes do nervo. Depois, leio a ressonância **à luz desse exame** e monto o plano de tratamento sem cirurgia, quando é o caso.

Quando há indicação de cirurgia de coluna, ou uma dúvida que pede quem opera coluna todos os dias, eu encaminho ao especialista em coluna. Encaminhar na hora certa faz parte de um cuidado honesto.

Agendamento: agendar.drrobertorodrigues.com

Instagram: @robertorodriguesmd

Atendimento em Fortaleza (CE).

Material educativo. Não substitui consulta médica. Nenhum tratamento tem resultado garantido. Cada caso precisa de avaliação individual.

1. Kreiner DS, Hwang SW, Easa JE, et al; North American Spine Society. **An evidence-based clinical guideline for the diagnosis and treatment of lumbar disc herniation with radiculopathy.** Spine J. 2014;14(1):180-191. doi:10.1016/j.spinee.2013.08.003. PMID: 24239490.
2. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). **Low back pain and sciatica in over 16s: assessment and management.** NICE guideline NG59. Publicada em 30/11/2016; atualizada em 2020 e em 2026. Disponível em: <https://www.nice.org.uk/guidance/ng59>
3. Finucane LM, Downie A, Mercer C, et al. **International Framework for Red Flags for Potential Serious Spinal Pathologies.** J Orthop Sports Phys Ther. 2020;50(7):350-372. doi:10.2519/jospt.2020.9971. PMID: 32438853.
4. Long B, Koyfman A, Gottlieb M. **Evaluation and management of cauda equina syndrome in the emergency department.** Am J Emerg Med. 2020;38(1):143-148. doi:10.1016/j.ajem.2019.158402. PMID: 31471075.
5. Jensen MC, Brant-Zawadzki MN, Obuchowski N, Modic MT, Malkasian D, Ross JS. **Magnetic resonance imaging of the lumbar spine in people without back pain.** N Engl J Med. 1994;331(2):69-73. doi:10.1056/NEJM199407143310201. PMID: 8208267.
6. Brinjikji W, Luetmer PH, Comstock B, et al. **Systematic literature review of imaging features of spinal degeneration in asymptomatic populations.** AJNR Am J Neuroradiol. 2015;36(4):811-816. doi:10.3174/ajnr.A4173. PMID: 25430861.
7. Chiu CC, Chuang TY, Chang KH, Wu CH, Lin PW, Hsu WY. **The probability of spontaneous regression of lumbar herniated disc: a systematic review.** Clin Rehabil. 2015;29(2):184-195. doi:10.1177/0269215514540919. PMID: 25009200.
8. Dahm KT, Brurberg KG, Jamtvedt G, Hagen KB. **Advice to rest in bed versus advice to stay active for acute low-back pain and sciatica.** Cochrane Database Syst Rev. 2010;(6):CD007612. doi:10.1002/14651858.CD007612.pub2. PMID: 20556780.
9. Peul WC, van Houwelingen HC, van den Hout WB, et al; Leiden-The Hague Spine Intervention Prognostic Study Group. **Surgery versus prolonged conservative treatment for sciatica.** N Engl J Med. 2007;356(22):2245-2256. doi:10.1056/NEJMoa064039. PMID: 17538084.
10. Jacobs WC, van Tulder M, Arts M, et al. **Surgery versus conservative management of sciatica due to a lumbar herniated disc: a systematic review.** Eur Spine J. 2011;20(4):513-522. doi:10.1007/s00586-010-1603-7. PMID: 20949289.
11. Lurie JD, Tosteson TD, Tosteson AN, et al. **Surgical versus nonoperative treatment for lumbar disc herniation: eight-year results for the Spine Patient Outcomes Research Trial.** Spine (Phila Pa 1976). 2014;39(1):3-16. doi:10.1097/BRS.0000000000000088. PMID: 24153171.
12. Bailey CS, Rasoulinejad P, Taylor D, et al. **Surgery versus conservative care for persistent sciatica lasting 4 to 12 months.** N Engl J Med. 2020;382(12):1093-1102. doi:10.1056/NEJMoa1912658. PMID: 32187469.
13. Overvest GM, Vleggeert-Lankamp CL, Jacobs WC, Brand R, Koes BW, Peul WC; Leiden-The Hague Spine Intervention Prognostic Study Group. **Recovery of motor deficit accompanying sciatica — subgroup analysis of a randomized controlled trial.** Spine J. 2014;14(9):1817-1824. doi:10.1016/j.spinee.2013.07.456. PMID: 24200407.
14. Miller LE, McGirt MJ, Garfin SR, Bono CM. **Association of annular defect width after lumbar discectomy with risk of symptom recurrence and reoperation: systematic review and meta-analysis of comparative studies.** Spine (Phila Pa 1976). 2018;43(5):E308-E315. doi:10.1097/BRS.0000000000002501. PMID: 29176471.

Material educativo. Não substitui consulta médica.

Dr. Roberto Rodrigues · CRM-CE 10806 · RQE 12256 · TEOT 17765